

Eduface testdag

Master Manuele Therapie

CAT diagnostiek · student 1 · destijds nagekeken op 09-12-2025

Naam _____ Datum _____

De beoordeling naast elkaar

	NAKIJKER	EDUFACE	
1. Algemeen	4 van 4 voldaan	FAIL	VERSCHIL
2. Klinisch scenario (stap 1)	2 van 3 voldaan	PASS	OMGEKEERD
3. Klinische vraagstelling (stap 2)	5 van 5 voldaan	PASS	EENS
4. Zoekstrategie (stap 3)	6 van 6 voldaan	FAIL	VERSCHIL
5. Kritische evaluatie (stap 4)	2 van 2 voldaan	PASS	EENS
6. Evidentietabel (stap 5)	2 van 2 voldaan	FAIL	VERSCHIL
7. Commentaar (stap 6)	2 van 2 voldaan	FAIL	VERSCHIL
8. Bottom line (stap 7)	1 van 1 voldaan	FAIL	VERSCHIL

NAKIJKER

24 van 25 voldaan

Eindoordeel: voldaan

EDUFACE

3 van 8 onderdelen PASS

Vijf onderdelen op FAIL

OVEREENSTEMMING

2 van de 8

Vijf keer strenger, één keer milder

De feedback die de nakijker destijds schreef

Het volledige feedbackveld, letterlijk overgenomen.

"Hey [student], Deze opdracht heb je afgerond. Je hebt hier en daar wel wat kort door de bocht uitgevoerd. Maar dat is bij deze opdracht nog niet z'n probleem."

Aantekeningen

Wat je opvalt terwijl we erdoorheen lopen

De volledige feedback van Eduface

Acht rubriekcriteria, letterlijk zoals het model ze schreef

1. Algemeen FAIL

De CAT bevat taal- en terminologiefouten en maakt redenering tussen stappen 1 tot 7 onvoldoende controleerbaar; vooral stap 4 tot 6 missen onderbouwing van interne validiteit, diagnostische kernmaten en bruikbaarheid. Dit verhindert navolgbaarheid. Corrigeer formuleringen en terminologie, verwijder ChatGPT-tekst; voeg zoekdatum, databank, zoektermen, voorafkants, in- en exclusiecriteria en berekeningen toe en verbind ze met bottom line.

2. Klinisch scenario (stap 1) PASS

Bij stap 1 presenteer je patiëntkenmerken en onderzoeksbevindingen kernachtig en verbind je deze logisch aan de hypothese. Echter, formuleer de hypothesen vóór de bevindingen en onderscheid welke bevindingen specifiek labrumletsel ondersteunen. Onderbouw de lage voorafkants (onder 10%) voor deze patiënt en corrigeer de genoemde taal- en grammaticafouten.

3. Klinische vraagstelling (stap 2) PASS

Je hebt de klinische vraag logisch opgebouwd: patiënt, indextest, referentietest, aandoening, NVW, voorafkants en beslisgrens zijn expliciet en toetsbaar verbonden. Echter, de voorafkants onder 10% is nog niet patiëntspecifiek onderbouwd. Harmoniseer vervolgens voorafkants, labrumletsel en referentietest en corrigeer de NVW/PVW-inconsistentie in bijlage 2.

4. Zoekstrategie (stap 3) FAIL

De reproduceerbaarheid van stap 3 en de onderbouwing van de artikelkeuze zijn incompleet; daardoor kan de lezer de zoekactie en casustoepasbaarheid niet controleren. Noteer datum, exacte PubMed-zoekstring met MeSH-termen en Booleaanse operatoren, faseaantallen en selectieargumenten. Vergelijk elk inclusie- en exclusie criterium met de casus.

5. Kritische evaluatie (stap 4) PASS

Je koppelt methodologische kenmerken terecht aan verificatie- en expectation bias en verbindt meerdere beperkingen aan Adib et al. (2023). Echter, maak in stap 4 per punt expliciet welk kenmerk welke bias en welk gevolg veroorzaakt. Bespreek in stap 5 referentiestandaard, beoordelaarsbetrouwbaarheid en work-up-, selectie- en spectrum bias.

6. Evidentietabel (stap 5) FAIL

Stap 5 en Bijlage 1 bevatten foutieve formules; daardoor zijn de berekeningen oncontroleerbaar. Noteer per maat formule, invulling, uitkomst en afronding, koppel waarden aan Tabel 1, corrigeer $0,94 \times 100$ en $0,33 \times 900$ en schrijf PVW als $94/697 = 13,5\%$. Orden artikel en 10%-voorafkants in hypothetische 2x2-tabellen van 1.000 personen.

7. Commentaar (stap 6) FAIL

Stap 6 werkt de klinische bruikbaarheid onvoldoende uit: de betekenis van een NVW van 0,98 en de lage specificiteit van 0,33 blijft onverbonden met patiënt en werkomgeving. Dit verhindert een onderbouwde toepasselijkheidsuitspraak. Bespreek wanneer een negatieve test MRA kan uitstellen en controleer berekeningen en bronnen.

8. Bottom line (stap 7) FAIL

Je Bottom Line maakt niet expliciet wat een negatieve Arlington-test betekent voor het diagnostische traject. Daardoor blijft de klinische handelingskeuze onduidelijk. Formuleer in één à twee zinnen of MRA direct geïndiceerd is en welke rol klinische follow-up speelt, rekening houdend met de beperkte generaliseerbaarheid.



Waar het uiteenloopt

Drie plekken waar de twee beoordelingen het verst uit elkaar liggen

Evidentietabel (stap 5)

NAKIJKER

Beide criteria voldaan. De tabel met sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarden werd goedgekeurd.

EDUFACE

FAIL. "Stap 5 en Bijlage 1 bevatten foutieve formules; daardoor zijn de berekeningen oncontroleerbaar. Corrigeer $0,94 \times 100$ en $0,33 \times 900$ en schrijf PVW als $94/697 = 13,5\%$."

Klopt die rekenkundige correctie? En als het klopt, is dit iets wat jullie zelf ook zouden willen zien?

Algemeen

NAKIJKER

Alle vier de criteria voldaan: taalgebruik, woordenaantal, samenhang en titel.

EDUFACE

FAIL. "De CAT bevat taal- en terminologiefouten (...) Corrigeer formuleringen en terminologie, verwijder ChatGPT-tekst."

Zijn die taalfouten terug te vinden in de tekst, en is de passage aan te wijzen die het model bedoelt?

Klinisch scenario (stap 1), hier lag de lat van de nakijker hoger

NAKIJKER

Niet voldaan op één punt: het accent op de klinische relevantie en de motivatie voor de klinische vraag ontbrak.

EDUFACE

PASS. Het model tekent er wel bij aan dat de lage voorafkans onder 10% niet patiëntspecifiek is onderbouwd.

Hier zag de nakijker iets dat het model niet noemt. Wat was dat, zodat we het kunnen meenemen?

De aannames van het model

Vier plekken waar het model iets invult dat de rubriek openlaat

Geen van deze vier is fout of goed. Het zijn keuzes, en jullie bepalen welke kant ze op gaan.

1. Eén spoor of meerdere sporen

HET MODEL SCHRIJFT "Formuleer de hypothesen vóór de bevindingen en onderscheid welke bevindingen specifiek labrumletsel ondersteunen."

DE RUBRIEK ZEGT het woord hypothesen, meervoud, zonder aantal

IN DEZE BEOORDELING is één onderbouwde hypothese gevolgd, met de bevindingen ernaartoe geredeneerd

Het model leest dat meervoud letterlijk en vraagt om een vergelijking tussen meerdere mogelijke oorzaken. Verwachten jullie dat ook, of is één goed onderbouwd spoor genoeg?

2. Hoe ver moet een zoekactie navolgbaar zijn

HET MODEL SCHRIJFT "Noteer datum, exacte PubMed-zoekstring met MeSH-termen en Booleaanse operatoren, faseaantallen en selectieargumenten. Vergelijk elk inclusie- en exclusiecriterium met de casus."

DE RUBRIEK ZEGT dat de zoekstrategie navolgbaar en reproduceerbaar is

IN DEZE BEOORDELING is een gemotiveerde keuze voor de gevonden artikelen voldoende bevonden, zonder dat de afgewezen artikelen apart besproken worden

Het model wil de zoekactie zo volledig dat iemand hem kan overdoen, inclusief de argumenten voor wat er afviel. Is dat wat jullie van een student op dit niveau verwachten?

3. Mag het model iets zeggen over de herkomst van de tekst

HET MODEL SCHRIJFT "Corrigeer formuleringen en terminologie, verwijder ChatGPT-tekst."

DE RUBRIEK ZEGT niets over de herkomst van de tekst

IN DEZE BEOORDELING is het taalgebruik als voldaan beoordeeld

Dit is het enige punt waarop het model buiten de rubriek treedt. Willen jullie dat het daar iets over zegt, en zo ja, hoe stellig mag dat zijn?

4. Weegt elk onderdeel apart, of het geheel

WAT HET MODEL DOET het beoordeelt elk onderdeel los en geeft vijf van de acht een FAIL

DE RUBRIEK ZEGT per criterium voldaan of niet voldaan, met een apart eindoordeel

IN DEZE BEOORDELING zijn 24 van de 25 criteria voldaan en is het eindoordeel voldaan

Het model zet elk onderdeel als een aparte drempel. In deze beoordeling woog het geheel mee. Welke van de twee past bij hoe jullie willen beoordelen?

Van de acht stukken feedback: hoeveel zou je ongewijzigd naar de student sturen?

Wat miste je, dat je zelf wél zou hebben opgemerkt?
